

تنظير المثانة (cystoscopy) يتيح للجراح رؤية الإحليل (مجرى البول) والمثانة من الداخل عبر منظار رفيع مزود بكاميرا وضوء، يُدخّل بلطف عبر فتحة البول الطبيعية. يساعد في تحديد سبب دم في البول، أو التهابات، أو تضيق، أو غيرها من مشكلات المثانة — وللتحقق من شفاء إصلاح سابق.

عن هذا الفحص

المنظار (cystoscope) أنبوب رفيع بكاميرا في طرفه. نوعان:

- المنظار المرن (القابل للانحناء) يُستخدم عادةً في العيادة وأنت مستيقظ مع جل تخدير موضعي.
- المنظار الصلب (المستقيم) يُستخدم في غرفة العمليات تحت التخدير، ويتيح للجراح العلاج في الزيارة ذاتها.

يُضخّ محلول معقم لفتح المثانة ورؤية جدرانها بوضوح. قد يطلب الجراح تنظيراً لـ:

- تحديد سبب دم في البول أو التهابات متكررة
- البحث عن تضيق أو حصوة أو نمو غير طبيعي
- متابعة شفاء إصلاح سابق، أو أخذ خزعة نسيجية صغيرة
- وضع stent أو التحقق منه أو إزالته، أو إزالة غرزة

هل هو آمن؟

نعم. تنظير المثانة من أكثر فحوصات المسالك البولية شيوعاً وهو منخفض الخطورة. يشعر معظم المرضى بانزعاج خفيف وعابر. الآثار غير الشائعة — كعدوى بولية خفيفة، أو نزيف طفيف، أو حرقنة قصيرة عند التبول — عادةً ما تزول سريعاً.

تعلم المصطلحات

Cystoscope

منظار رفيع بكاميرا وضوء لفحص الإحليل والمثانة من الداخل.

المثانة

الكيس العضلي الذي يخزن البول حتى يتم التبول.

الإحليل (مجرى البول)

الأنبوب الذي يخرج منه البول من الجسم.

مرن أو صلب

المنظار المرن للعيادة (مستيقظ)؛ الصلب لغرفة العمليات (تحت التخدير).

جل التخدير الموضعي

مادة مخدرة تُوضع في الإحليل لتسهيل إدخال المنظار بشكل مريح.

خزعة

عينة نسيجية صغيرة تُفحص تحت المجهر.

Stent

أنبوب ناعم يبقي القناة مفتوحة؛ يُوضع أو يُزال أثناء الفحص.

البول المتبقي بعد التبول

كمية البول التي تبقى في المثانة بعد التبول.

هل سيؤلم؟ مع المنظار المرن قد تشعر بضغط خفيف أو وخز لحظي عند دخوله — جل التخدير يخفف ذلك، وعادةً ينتهي فحص العيادة في دقائق. مع المنظار الصلب أنت تحت التخدير ولا تشعر بشيء أثناءه. أخبر الفريق الطبي فور الشعور بأي انزعاج.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

بعد الفحص

- لتنظير العيادة (المرن) يمكنك عادةً الأكل والشرب وتناول أدويةك المعتادة، والعودة إلى المنزل بنفسك.
- لتنظير تحت التخدير، اتبع تعليمات الجراحة: الصيام، وأي أدوية تُوقف، ورتّب وسيلة إيصال.
- قد يُطلب منك عيّنة بول للتحقق من وجود عدوى، وربما يُصف لك مضاد حيوي.
- أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:
 - تتناول مميعاً للدم
 - لديك أعراض عدوى بولية (حرقة، حمى، أو بول عكر كريه الرائحة) — قد يُؤجّل الفحص عند وجود عدوى نشطة
 - لديك حساسية، أو تضيق سبق إدخال المنظار في المرات السابقة

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 تستلقي مرتاحاً ويساعدك الفريق في اتخاذ الوضعية المناسبة. تُنظف فتحة البول ويُوضع جل التخدير.
- 2 يُدخل المنظار بلطف عبر الإحليل حتى المثانة.
- 3 يُضخّ محلول معقم لفتح المثانة، ويفحص الجراح جدارها الداخلي بالكامل.
- 4 يُسحب المنظار. وإن كان مقررًا علاج أو خزعة أو تغيير stent، يُنجز قبل سحبه.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- صعوبة في التبول، أو عدم القدرة على التبول كلياً
- نزيف غزير، أو جلطات دموية في البول
- ألم يزداد بدلاً من أن يتحسن

ثلاثة أمور تتكرها

1. تنظير المثانة فحص سريع وآمن داخل مئانتك والإحليل بكاميرا رفيعة — يساعد جراحك في تشخيص المشكلة أو متابعة الإصلاح.
2. لا يتطلب فحص العيادة تحضيراً خاصاً. للتنظير تحت التخدير، اتبع تعليمات الصيام ورتّب وسيلة إيصال، وأخبر فريقك عن مميّعات الدم أو أي أعراض عدوى.
3. حرقة خفيفة أو لون وردي في البول ليوم أمر طبيعي — اشرب الماء بكثرة، واتصل فوراً عند الحمى أو نزيف غزير أو صعوبة في التبول.